MEDSINA 2027

MIND MAP : ASTHME DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT

Module de Pneumologie • Préparation Officielle Concours de Résidanat

GOOGLE DRIVE CLOUD

1 Définition & Physiopathologie

- Maladie inflammatoire chronique des voies aériennes caractérisée par une hyperréactivité
- Terrain atopique fréquent (rhinite, conjonctivite, eczéma, antécédents familiaux).

2 Démarche Diagnostique

- Symptômes évocateurs : Dyspnée paroxystique sifflante à prédominance nocturne ou au petit
- Confirmation fonctionnelle obligatoire (EFR - Spirométrie) :
- Trouble Ventilatoire Obstructif (TVO) : Rapport VEMS / CVF (indice de Tiffeneau) < 70% (ou < LIN).
- Test de réversibilité positif : Augmentation du VEMS de > 12% ET > 200 mL 15 minutes après

3 Évaluation du Contrôle (Critères GINA -

- Évalue 4 critères au cours des 4 dernières semaines :
- Symptômes diurnes > 2 fois par semaine ?
- Réveils nocturnes liés à l'asthme ?
- Prise de traitement de secours (BDCA) > 2 fois par semaine ?

4 Stratégie Thérapeutique de Fond (Recomma

- Règle fondamentale : Le traitement de fond repose sur les Corticoïdes Inhalés (CSI).
- Paliers thérapeutiques :
- Palier 1-2 : CSI à faible dose + Formotérol (CSI-BDLA) à la demande (traitement de crise et de
- Palier 3 : CSI faible dose + BDLA (ex: Budésonide + Formotérol) en prise quotidienne régulière.

CŒUR DU SUJET CLINIQUE

Asthme de l'Adulte et de l'Enfant

Algorithme & Notions Haute Tombabilité

5 Crise d'Asthme Aigu Grave (AAG) : Urgenc

- Signes de gravité extrême (Imminence d'arrêt respiratoire) :
- Silence auscultatoire (« poumon muet »), bradypnée ou respiration paradoxale abdominale.
- Troubles de la conscience, agitation extrême ou coma, sueurs profuses, cyanose.
- Instabilité hémodynamique : collapsus, bradycardie.

6 Pièges Concours & Vigilance Annales

- Piège Annales : Ne JAMAIS prescrire de bêta-2 agoniste de longue durée d'action (BDLA) en
- Piège Gazométrie : Chez un patient asthmatique en tachypnée, la gazométrie normale montre une
- Piège AINS : L'aspirine et les AINS sont contre-indiqués chez le patient avec syndrome de

7 Points Clés Incontournables

- Diagnostic formel par EFR : TVO réversible (gain VEMS > 12% et > 200 mL sous Salbutamol).
- La pierre angulaire du traitement de fond est le Corticoïde Inhalé (CSI), jamais de BDLA seul !
- Évaluation du contrôle selon les 4 critères GINA (symptômes diurnes, nocturnes, secours, activité).
- Une PaCO2 normale ou élevée lors d'une crise d'asthme signifie épuisement respiratoire aigu =

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES : EFR: VEMS/CVF < 70% avec réversibilité significative (VEMS +12% ET +200 mL post-bronchodilatateur)

TRAITEMENT CLÉ : Fond: Corticoïde Inhalé (CSI) + Formotérol (BDLA) par paliers GINA 1 à 5; Crise: Salbutamol nébulisé 5mg + Ipratropium +